

1 薬剤の分類マップ

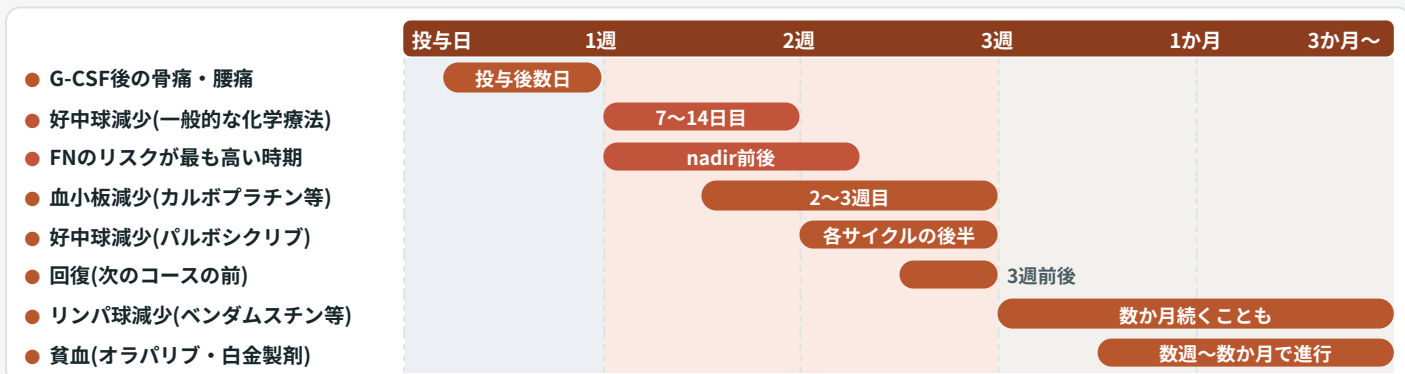
細胞障害性抗がん薬 骨髄の造血細胞を障害	好中球減少が強い	ドセタキセル	ドキソルビシン	イリノテカン	FTD/TPI		
	血小板減少が目立つ	カルボプラチン	ゲムシタビン	貧血	シスプラチン	カルボプラチン	
分子標的薬 造血にも関わる経路を阻害	CDK4/6阻害薬	バルボシクリブ	アベマシクリブ	PARP阻害薬	オラパリブ	ニラパリブ	
	BCR-ABL阻害薬	ダサチニブ	イマチニブ				
血液がんの治療 強い骨髄抑制・リンパ球減少	多剤併用・細胞療法	R-CHOP	ベンダムスチン	CAR-T細胞療法	免疫調節薬	レナリドミド	ポマリドミド
支持療法 FNの予防・治療・感染予防	G-CSF製剤	フィルグラスチム	ペグフィルグラスチム				
	外来FNの経口抗菌薬	レボフロキサシン	アモキシシリン・クラバン酸	感染予防	ST合剤	アシクロビル	

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 重症度(CTCAE Grade)と保険薬局での対応

Grade	好中球数(/ μ L)	血小板数(/ μ L)	保険薬局での対応
Grade1	基準値下限未満～1,500	基準値下限未満～75,000	感染予防・体温測定の実行を確認
Grade2	1,500未満～1,000	75,000未満～50,000	発熱時の連絡方法を再確認
Grade3	1,000未満～500	50,000未満～25,000	発熱・出血症状があれば至急連絡するよう指導
Grade4	500未満	25,000未満	発熱は即受診(FN)、出血に厳重注意

3 副作用の特徴と発現時期



☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

押さえておきたいポイント

- 好中球のnadirは投与7～14日目。この時期の発熱はFNを疑い、解熱剤で様子を見ずに受診
- FN予防はレジメンのリスクでG-CSFを判断、発症時は患者のリスクで外来・入院治療を判断
- 発熱時の対応フローの事前共有と、nadir期の電話フォローが薬局の重要な役割